

Resumo

Este documento é um guia detalhado e pessoal para a recuperação do vício, escrito por um adicto em recuperação que se tornou conselheiro. Ele descreve uma abordagem em cinco fases para superar o vício, concentrando-se nas dependências de substâncias, comportamentos e nas situações que servem de gatilho para o consumo de substâncias químicas, tanto lícitas quanto ilícitas, usadas como fuga da realidade, para alcançar auto aceitação e inserção social. O autor enfatiza a importância de reconhecer esse tipo de atitude como um problema de saúde, para buscar ajuda e compreender como os mecanismos do vício são ativados e, a partir disso, propor o desenvolvimento de um plano personalizado de recuperação. O guia descreve etapas específicas para cada fase: o reconhecimento da dependência química, incluindo estratégias para controlar os desejos; a construção de novas rotinas e hábitos saudáveis; e como construir uma rede de apoio emocional que permita ao adicto lidar com emoções difíceis e enfrentar o vício.

Este texto salienta a natureza contínua da recuperação da dependência, reconhecendo o potencial de recaída e oferecendo orientação sobre como gerenciá-la. Em última análise, o documento visa capacitar os indivíduos que lutam contra a dependência, fornecendo uma estrutura para compreender, navegar e, finalmente, superar seus desafios.

Como Domar os Vícios

Manual simplificado do tratamento prático da adicção.
Passo a passo para uma vida saudável longe de adicção

Guia de recuperação de vícios

I. Compreendendo o vício:

Definição: Doença crônica que requer tratamento

Impacto: Afeta o indivíduo e aqueles ao seu redor

Experiência Pessoal: A jornada do autor informa o guia

II. Reconhecendo o vício:

Características: Uso ou comportamentos compulsivos de substâncias

Questões subjacentes: Problemas de identidade, depressão, vazios pessoais

Auto-avaliação: Exemplos ajudam os leitores a avaliar seus próprios hábitos

III. Fase Um: Os Primeiros 30 Dias - Abraçando a Abstinência:

Desintoxicação: Importância da abstinência completa (paciente internado ou desintoxicação domiciliar monitorada)

Gerenciamento de dopamina: Compreendendo o papel da dopamina no vício e na abstinência

IV. Fase Dois: Regime Semiaberto - Explorando Gatilhos e Construindo Mecanismos de Enfrentamento:

Reintegração Gradual: Passeios supervisionados, orientação profissional (psiquiatra, terapeuta)

Gerenciamento de gatilhos: Identificar gatilhos pessoais (pessoas, lugares, situações)

"Sistema de luzes" para categorizar e navegar pelos níveis de risco

Honestidade e autoconsciência: Importância da honestidade na recuperação

V. Fase Três: Aprofundando a Autocompreensão – Descobrendo as Raízes da Compulsão:

Suporte de longo prazo: Grupos de terapia e apoio para compreender os mecanismos de dependência

Natureza crônica do vício: Comparação com doenças crônicas como diabetes

Importância da gestão ao longo da vida, vigilância e reconhecimento de sinais de alerta

Plano de prevenção de recaídas: Identificando gatilhos pessoais

Desenvolvendo mecanismos de enfrentamento

Estabelecendo uma rede de apoio

VI. Fase Quatro: Manter o ímpeto – Perseverança e Responsabilidade:

Importância da rotina e suporte: Particularmente crucial durante o primeiro ano de recuperação

Combatendo a Complacência: O vício não é “curado” – requer gerenciamento contínuo

Evitando a falsa sensação de segurança

Gatilhos comuns de recaída: Excesso de confiança, romantização do uso passado, isolamento, falta de propósito, situações de alto risco

VII. Fase Cinco: Abraçando uma Nova Identidade - Vivendo uma Vida Plena em Recuperação:

Construindo uma vida satisfatória: Concentre-se na realização sem depender de substâncias ou comportamentos viciantes

Gerenciando a exposição e construindo hábitos saudáveis:

Estratégias para gerenciamento de tempo de exposição

VIII. Conclusão: Abraçando a Liberdade e Encontrando a Realização

Como tenho certeza de que sou viciado? Seja em substâncias ou comportamentos compulsivos.

Existem diversas formas técnicas de caracterizar o uso de alguma substância ou comportamento compulsivo nos manuais técnicos sobre adicção. Eu, aqui, não vou falar deles, pois falarei sobre a minha experiência como adicto em tratamento e o que funciona para mim. Por isso, resolvi montar este manual para ajudar todos aqueles que têm problemas com adicção ou aqueles que conhecem alguém que tenha esse problema.

Eu me tornei conselheiro de uma clínica de reabilitação particular em São Paulo em 2024, depois de 4 anos de tratamento nesta mesma clínica. Tive uma recuperação longa, pois lutei muito no começo do tratamento por conta do preconceito. Eu achava que meu problema era somente com o consumo abusivo de cocaína e não tinha relação nenhuma com o álcool. Com algum tempo e algumas recaídas, entendi que o álcool é parte integrante da minha droga de escolha e que eu deveria evitá-lo. Desde então, comecei a viver uma vida sem o álcool. Nem preciso dizer aqui que minha vida mudou 180 graus com a retirada do álcool: passei a priorizar tempo com a família, amigos próximos, eventos escolhidos a dedo, viagens pacíficas e enriquecedoras, trabalho em projetos interessantes e me dedicar a ajudar outras pessoas com o mesmo propósito.

A recuperação pode ser longa, mas durante o progresso você vai ganhando presentes da vida, motivando-o a ir cada vez mais longe, pois existem sim recompensas pelo trabalho árduo do tratamento contra vícios. Começa, então, com o corpo tendo muito tempo para descansar e entrar em um ciclo de sono normal, deixando-o muito disposto e com a cabeça extremamente criativa e leve, afastando a culpa e a vergonha, tão presentes na vida de um adicto. Você começará a ter tempo para academia e outros hábitos saudáveis, o que o levará a ter um corpo e rosto mais bonitos, naturalmente. Você passa a escolher as melhores pessoas para fazerem parte de sua vida, o que o torna cada vez mais interessante.

Por alguma razão, você começará a ter sorte; tudo começa a cair no lugar certo e as coisas, em geral, começam a melhorar para você. Resumindo, eu sigo em tratamento e sigo ganhando presentes da vida com o meu progresso.

Caracterizar uma pessoa como sendo adicta a alguma substância ou comportamento compulsivo é algo muito particular. Eu considero que todos os adictos são, em diferentes níveis, pessoas compulsivas, e isso é genético. A adicção é uma doença crônica, comprovada por várias secretarias de saúde no mundo todo. Como tal, deve ser tratada como uma doença e não simplesmente como vagabundagem.

Para mim, uma pessoa viciada ou compulsiva em algum comportamento psíquico é aquela cujo uso abusivo de alguma substância psicoativa ou comportamento compulsivo existe para sanar algum problema de identidade, depressão ou falta. Exemplo: se você bebe álcool porque precisa esquecer os problemas, esconder baixa autoestima, alterar o humor ou para entrar em estado de euforia, e esse uso for compulsivo, aquele cujo uso não é mais controlável depois das primeiras doses, ou vai até quase passar mal ou passa mal, eu diria que você tem um problema com vício. No começo, ele aparece disfarçado de um sentimento gostoso e que te deixa sentir como se fosse um super-herói. Com o tempo, as pessoas começam a reclamar do seu uso abusivo de substâncias psicoativas e você começa a usar tal substância sozinho, passando a se afastar dos amigos e entes queridos. Torna-se natural a aproximação e a construção de relacionamentos afetivos com pessoas que também fazem uso dessa mesma substância ou de qualquer outra; o importante é que não serão mais julgados. No fim, o uso já é praticamente diário, impedindo-o de exercer seu trabalho de forma responsável, cortando elos familiares e procurando sempre maneiras e ocasiões para usar sua droga de escolha. Os problemas de saúde surgirão nesta etapa, junto ao sentimento de não pertencimento, depressão, desespero, paranoia, falta de dignidade, etc. A substância passa a ser o grande amor da sua vida; nada consegue te afastar dela, nem mesmo você.

Geralmente, quando você se encontra nesta última etapa, procura maneiras de controlar seu vício, mas logo percebe que não consegue fazê-lo. O dinheiro vai se acabando e você começa a procurar maneiras desagradáveis de conseguir dinheiro para a sua droga de escolha. Aqui começa o envolvimento com dealers ou donos de estabelecimentos que tomam proveito de você. Muitos acham que, nessa etapa, o usuário já chegou no "fundo do poço", mas saiba que o mesmo pode ter subsolo... Tudo começa a ir ladeira abaixo, até a perda total de sua identidade original e, muito provavelmente, a morte. Pode parecer até um pouco dramático demais o que descrevi, mas é absolutamente verdade e real.

Então, voltando ao exemplo da bebida: se você bebe somente nos fins de semana e depois começa a comprar bebida para tomar em casa durante a semana, às vezes depois do trabalho ou durante o jantar, e depois disso se vê bebendo uma garrafa de vinho por dia, você já é um adicto. Tente parar ou controlar o uso urgentemente. Se não conseguir, procure alguém para conversar sobre isso. Dependendo do estágio em que você está e da quantidade de vezes que tentou parar, é provável que precise deste manual aqui para entender melhor o tratamento. Este manual, ou guia, é baseado na minha vivência com adicção e em tudo o que aprendi para me tornar um conselheiro.

Primeira fase:

"Reconheço que tenho um problema e preciso de ajuda".

Se você conseguir, pode internar-se em alguma clínica de reabilitação por 30 dias; caso contrário, interne-se em casa. Quando eu digo internar-se em casa, quero dizer não sair de casa para nada durante pelo menos 30 dias. Use delivery de supermercado ou refeições para não precisar sair de casa. Se tiver um parceiro ou família, peça-lhes que o monitore via fechadura eletrônica, daquelas que alertam quando a porta foi aberta ou trancada e mostram os horários de movimentação via algum app. Instale câmeras pela casa para fácil monitoramento.

Elimine todas as garrafas de qualquer bebida alcoólica, e até mesmo Listerine, da casa. Jogue tudo fora, nada de "guardar a sete chaves". Peça a algum membro de sua família para fazer uma varredura no quarto do usuário sem a presença dele. Retire tudo o que for relacionado à droga de escolha e jogue no lixo. As drogas devem ser jogadas em vasos sanitários, sem seus pacotes, obviamente, e dar-se-á descarga.

Quando falamos sobre vícios comportamentais, como ao sexo, jogos, compras, a limpeza deve ser adaptada ao comportamento abusivo. Se for sexo, elimine televisões, computadores, celulares, tablets, revistas e livros do ambiente em que o adicto irá residir pelos próximos 30 dias. O parceiro ou a família será muito importantes nesse processo; delegue tarefas de casa para cada membro da família relacionadas ao seu tratamento. O importante aqui é ficar longe do seu objeto de compulsão. Se o paciente (vou começar a chamar o usuário ou adicto de paciente pois acho mais digno) tem alguém da família em quem confia, este pode ser designado como o acompanhante do paciente. Este membro estará ali para conversar e ajudar quando aparecer algum sintoma de abstinência doloroso ou apenas o desejo de uso.

Esse tempo isolado irá diminuir o estado de agitação do paciente e prepará-lo para os próximos passos.

A dopamina é o maior inimigo destes pacientes!

Na vida normal de uma pessoa, a dopamina é o incentivo para o desenvolvimento de habilidades e ambições. Na vida de um adicto, ou pessoa compulsiva, a liberação de dopamina se encontra tão desregulada que torna a capacidade de sentir prazer por coisas banais ou naturais do dia a dia impossível, por conta do uso abusivo de substâncias que geram prazer imediato. O resultado disso é uma montanha-russa de emoções, muito parecidas com o transtorno bipolar.

TABELA DOPAMINERGICA NO COMEÇO DO USO

estado basal	2%
bolo de chocolate	18%
vinho	32%
sexo	58%
cocaína	90%

estado basal

estado com mínimo impacto de dopamina

bolo

deliciar-se em um belo bolo de chocolate

vinho

uma ou duas tacinhas de vinho com os amigos

sexo

quanto mais perigoso ele for, mais liberação de dopamina ele terá

cocaína

uma única carreira pode liberar todo seu arsenal de dopamina de uma vez.

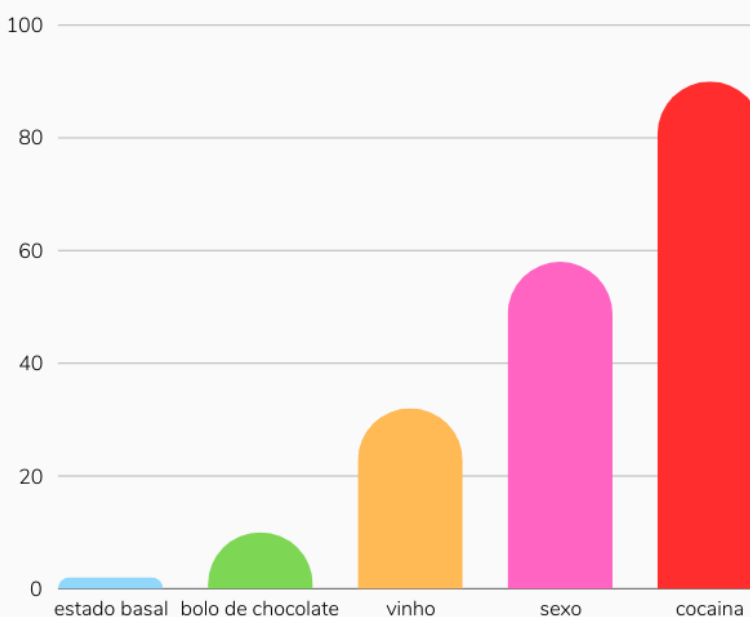
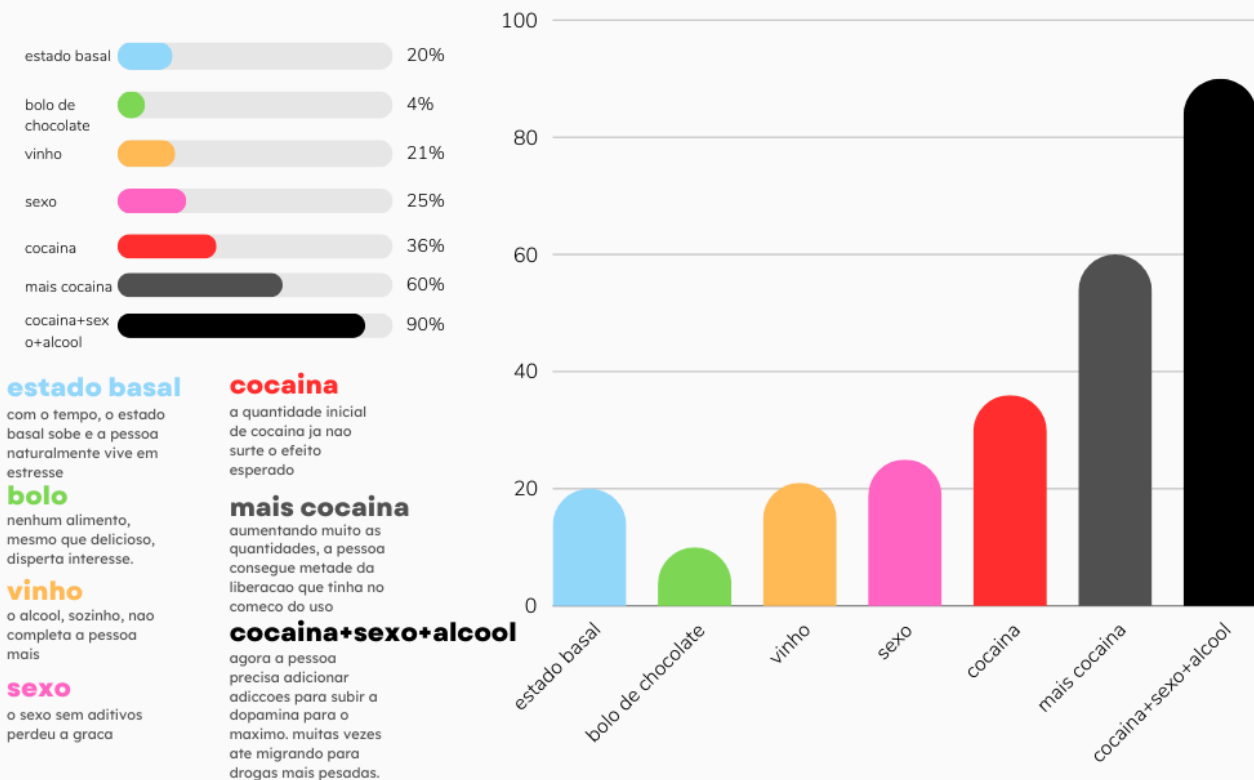


TABELA DOPAMINERGICA COM MUITO TEMPO DE USO



O ser humano tem um sistema basal de recompensa por meio de ações dopaminérgicas: quando você come um doce gostoso, você tem uma elevação de dopamina a partir do seu estado basal. Quando você faz sexo, há um aumento significativo de dopamina, superior ao do doce. Quando você ganha na loteria ou recebe um presente muito inesperado, como um carro de luxo ou imóvel, essa liberação dopaminérgica é ainda maior. Quando você usa cocaína ou algum outro estimulante de mesma potência, a liberação de dopamina é estratosférica; nada consegue competir com esse estímulo. Por isso, a pessoa geneticamente predisposta à compulsão tem altas chances de se viciar.

O objetivo aqui é manter essa liberação de dopamina o mais próximo ao basal possível, ou seja, ter o mínimo de estímulos possível para que esse tratamento funcione.

Isso quer dizer que o paciente passará por grandes dificuldades quando não estiver mais recebendo dose nenhuma de dopamina ao longo do dia. Ele, assim, ficará extremamente triste e ocioso. Muitas vezes, irritado. Muitas vezes, agressivo. Então, é muito importante manter a calma e entender que este desconforto passará em alguns dias. Não se deixe levar pelas tentativas insistentes de abandono do tratamento. Lembre-o de como estava a sua vida antes de decidir parar de usar drogas ou de ter comportamento compulsivo. Mantenha-se sereno. Isso é uma doença muito complicada; tanto o paciente quanto o acompanhante, ou responsável, deverão ser resilientes.

Durante estes 30 dias, a alimentação precisa ser regrada e sem grandes alterações, nada de muitos doces ou comidas muito exóticas. Nada de televisão o dia todo ou filmes que mexam muito com o emocional das pessoas. Nada de internet; aliás, redes sociais devem ser extintas e grupos de WhatsApp eliminados. O telefone, por ser um possível meio de contato com dealers ou pessoas que possam prover a sua droga de escolha, precisa ser guardado em algum cofre ou gaveta com chaves, escondido mesmo.

Os familiares, e quando eu digo familiares, falo sobre pessoas que moram com o paciente, não podem deixar cartões de crédito, celulares ou dinheiro jogado pela casa. Seria interessante guardá-los em cofres ou gavetas com chave.

Caso o paciente prefira se internar em uma casa de repouso ou centro de reabilitação, esses cuidados não serão necessários, pois, dependendo dos centros de reabilitação, eles cuidarão desse processo de segurança.

Internações: Existem basicamente dois tipos de internações:

Obs: o paciente pode ser removido por ambulância de sua casa via pedidos da família ou cônjuges. Neste caso, o paciente só sairá da internação se os mesmos autorizarem a saída. Ou o paciente pode pedir para ser internado e entrar por conta própria, independentemente de quem pagará a conta, assim dando um pouco mais de poder ao paciente sobre seu próprio tratamento.

Casas de Repouso:

Nessas instituições, não existe um tratamento específico para a adicção. Os pacientes têm um lugar para se afastar das drogas, sejam elas ilícitas ou lícitas. Geralmente, existem psicólogos e psiquiatras in loco, mas estes tratam superficialmente o paciente e estão disponíveis em casos de emergência. Estas internações não possuem grupos de apoio ou tratamento farmacológico; para isso, o paciente deve ter o seu próprio psiquiatra fora da clínica. Da mesma forma funciona o tratamento psicológico; o paciente precisa ter contato com esse profissional fora da clínica.

Não consigo enfatizar o suficiente a necessidade de um bom psiquiatra, que trabalha na área de adicção, e de um gerente terapêutico ou psicólogo, também especializado em adicção. Os preços destas casas de repouso podem variar de gratuitas, pagas pelo governo, a R\$30.000 por mês, dependendo das condições financeiras da família. Geralmente, planos de saúde cobrem a estadia em casas de repouso pré-determinadas pelo plano de saúde. No entanto, as melhores casas de repouso não aceitam nenhum plano de saúde como pagamento, sendo necessário o pagamento adiantado.

Se esse for o retiro escolhido pelo responsável, certifique-se da qualidade dos serviços propostos nesta internação e da qualidade dos profissionais. Se for um lugar sem muita qualidade, com profissionais ruins e instalações precárias, eu acho mais vantajoso interná-lo em casa mesmo. No caso do paciente estar em um estágio avançado, muito agressivo e colocando em risco outros membros da família, este deve ser internado em alguma casa de repouso.

Enfim, a família ou o responsável poderá avaliar as opções e optar pela forma que faz mais sentido no caso do paciente. Dentro dessa internação, variando muito dependendo da escolha, o paciente terá um quarto com banheiro, geralmente dividido com um ou mais integrantes. A alimentação é toda por conta da internação, com horários rígidos para as refeições.

Algumas casas de repouso oferecem ambientes para pintura, exercícios, leitura ou até televisão, a fim de entreter os pacientes.

As consultas com psiquiatra ou psicólogo podem ser feitas por vídeo chamada ou até presencialmente, quando o profissional opta por ir à casa de repouso para a sessão de terapia.

Clínicas de Reabilitação:

Neste caso, o paciente recebe todo o suporte psiquiátrico e terapêutico necessário e específico para cada situação. Dentro da internação, existem regras e rotinas extremamente importantes para o tratamento. A parte farmacológica também é levada em conta, e geralmente o paciente é medicado ao ingressar na internação.

Existem grupos de apoio durante o dia todo, para que o paciente possa conversar sobre sua vida e entender melhor sua adicção. O valor dessas clínicas geralmente é bem alto e existem poucas no mercado, além de, na maioria, não aceitarem planos de saúde.

Existem clínicas gratuitas pelo SUS e algumas cobertas por planos de saúde, mas como são poucas opções por cidade, essas vagas são muito concorridas e limitadas.

Dentro de uma clínica de recuperação, o paciente tem o dia completamente organizado, com diversos grupos de apoio, atendimento com o psiquiatra e com o gerente terapêutico. Há horários para lazer, exercícios, atividades artísticas e outras atividades em grupo.

Segunda fase:

Está na hora de começar a entender a adicção e por que você se viciou.

Após esses 30 dias emergenciais, o paciente estará, naturalmente, mais propenso a um tratamento psicológico profundo. Ele agora consegue compreender melhor suas compulsões e está em condições de sentar para conversar sobre isso. É aqui que entra o regime semi-aberto:

Este regime semi-aberto permite a saída do paciente, acompanhado de alguém responsável por ele. Algumas famílias contratam acompanhantes de pacientes, que são profissionais treinados para essa função em clínicas de recuperação. Normalmente, eles são psicólogos, mas não necessariamente precisam ser. O fundamental é que estejam bem treinados em adicção e compreendam profundamente a doença.

O acompanhante do paciente sairá com ele para realizar tarefas normais, ou até mesmo de lazer, fora de casa. Caso a família não tenha condições de contratar esse profissional, algum membro da família poderá assumir essa função.

O importante é não deixar o paciente sozinho, prestar muita atenção em todas as reações que ele tiver a certos tipos de exposição e estar disposto a conversar sobre o que se passa em sua cabeça durante essas saídas.

O responsável precisará procurar um psiquiatra ou até mesmo um psicólogo para iniciar o trabalho de desconstrução da vida passada, aquela em que a adicção dominava, e construção de uma nova vida, onde as compulsões estão sob controle. Explico aqui: as compulsões não desaparecem completamente da vida de um adicto. Durante o tratamento, aprendemos a eliminar as compulsões mais prejudiciais para nós, aquelas que realmente destroem nossa vida.

Mas entenda que o adicto precisará sempre observar e controlar suas compulsões diariamente.

Por isso, é tão importante um bom trabalho psicológico, pois, com o tempo, o paciente conseguirá obter ferramentas para controlar essas compulsões. É importante salientar que esses profissionais devem ter experiência em adicção para serem considerados adequados para o tratamento.

O telefone e as redes sociais ainda não podem ser liberados, a menos que o paciente precise deles para trabalhar. Nesse caso, deve ser feito um trabalho de limpeza no celular para apagar conteúdos e contatos preocupantes que possam colocar o paciente em risco. O ideal é que o paciente troque de celular e de número, mas, muitas vezes, isso não é possível. Nesse cenário, o responsável pelo paciente deve ser extremamente criterioso e eliminar tudo relacionado ao uso de drogas, álcool ou comportamentos compulsivos. Eu aconselho pedir ao paciente que escreva, em papel, cada contato necessário no telefone, salve as fotos e outros arquivos no computador e, então, deleta o telefone inteiro. Após isso, ao adicionar os números e arquivos restantes, certifique-se de apagar todo o histórico do WhatsApp. Nós, adictos em recuperação, sempre encontramos uma maneira de esconder um contato no celular para aquele momento de desesperança e fraqueza; portanto, elimine essa tentativa de sabotagem logo no início.

Sobre amigos: o paciente deve, sempre que possível, evitar pessoas que possam colocá-lo em risco, lugares onde a droga de escolha foi utilizada ou que tenham fácil acesso a essas substâncias, e situações que o levem a pensar em usá-las.

Todo e qualquer amigo que utilize, tenha utilizado ou seja um facilitador de uso de drogas ou álcool deve, infelizmente, ser excluído da vida do paciente.

Isso pode parecer muito drástico, mas com o tempo e a criação de novos hábitos saudáveis, essa dor pela perda de amigos e, muitas vezes, até de parceiros, irá gradualmente diminuir até que o paciente não sinta mais saudades nem a necessidade de se encontrar com essas pessoas.

É de extrema importância esse passo. Elimine-os sem dó!

Lugares: O paciente deve evitar locais onde a droga é usada amplamente ou onde ele mesmo a utilizou. Muitas vezes, um adicto ao álcool não poderá frequentar bares e restaurantes por um bom tempo. Festas e baladas seriam completamente fora de cogitação nesta fase do tratamento.

Se o paciente usava a substância de sua escolha em casa, e sozinho, esse ambiente precisa ser reavaliado. Muitas vezes, mudar de residência pode ser a melhor opção. Caso não seja possível, um trabalho de ressignificação com um psicólogo ou conselheiro pode ajudar a transformar esse ambiente em um lugar seguro.

Esse trabalho nada mais é do que uma "limpeza geral" da casa, retirando qualquer substância psicoativa, e, claro, o álcool. Após a limpeza, acompanhada de um terapeuta ou conselheiro, algumas sessões dentro de casa podem ser necessárias para ajudar o paciente a viver nesse ambiente sem ser constantemente remetido às memórias eufóricas do uso de drogas ou aos hábitos que levam a lembranças dolorosas das consequências do uso abusivo de substâncias psicoativas, ou de comportamentos compulsivos.

Obs: O conselheiro atua como um parceiro durante a recuperação. Ele ajudará no dia a dia do paciente, oferecendo apoio em momentos de lazer, enfrentando dificuldades ou até emergências. Esse profissional é capacitado para acolher o paciente sempre que ele precisar de auxílio, claro, relacionado ao tratamento.

Situações: Neste caso, as regras devem ser adaptadas às características específicas da adicção de cada paciente. Essas situações envolvem momentos em que a lembrança do uso, ou a euforia da antecipação do uso, tornam praticamente impossível resistir ao chamado agonizante para consumir drogas. Para muitos, o próprio ócio pode ser uma situação alarmante; para outros, uma agenda excessivamente atarefada pode levá-los a pensar ou desejar o uso.

Às vezes, uma pessoa em particular pode desencadear uma recaída, por isso é crucial que essas situações sejam analisadas com atenção, identificadas e monitoradas de perto.

Por isso, é tão importante compreender profundamente a própria adicção, e a terapia é a melhor ferramenta para alcançar esse entendimento.

Regra básica para facilitar o controle dessas três áreas:

Luz vermelha: Lugares, situações e pessoas que estão extremamente ligadas ao uso da substância psicoativa. Devem ser evitados a todo custo.

Luz amarela: Lugares, situações e pessoas que estão de certa forma ligadas ao uso de substâncias psicoativas, mas que o paciente consegue tolerar, desde que não abuse dessas situações.

Luz verde: Lugares, situações e pessoas que não estão de maneira alguma relacionadas ao uso de drogas.

Vou dar exemplos aqui para facilitar o entendimento deste sistema de luzes:

No começo do meu tratamento, por ser viciado em cocaína e álcool, eu gostava muito de festas e encontros na casa de amigos. Nessas situações, eu costumava usar o banheiro para consumir cocaína sempre que possível. Por isso, festas ou encontros na casa de amigos passaram a ser luz vermelha para mim.

Bares e restaurantes, no começo do tratamento, também eram luz vermelha. Baladas e grandes festas também.

Eu havia cortado relações com as pessoas que usavam cocaína, mas não havia cortado relações com as pessoas que consumiam álcool. Então, essas pessoas passaram a ser luz amarela para mim, porque eu conseguia encontrá-las em lugares controlados, mas por um curto período de tempo. Com o passar dos anos, passei a frequentar restaurantes e alguns bares, movendo esses lugares para a categoria de luz amarela. E assim fui progredindo para luz **verde**.

Esse sistema de luzes é uma maneira muito útil de monitorar e gerenciar o ambiente ao redor, criando uma estrutura para evitar recaídas e controlar as situações que podem ser mais desafiadoras para o paciente. A honestidade consigo mesmo é, sem dúvida, a chave para que isso funcione. Continuar a trabalhar nessa autorreflexão e aceitação das limitações durante o processo é essencial para o sucesso.

Aliás, a honestidade começa a ser **priorizada** com muito vigor nesta fase do tratamento. O paciente precisa entender que qualquer mentira ou omissão, mesmo que seja a chamada **mentira branca** ou leve, deve ser evitada.

Quando o paciente começa a notar que está mentindo ou omitindo, indubitavelmente uma recaída ou um lapso está no horizonte. O paciente terá que querer **de fato** se reabilitar, pois esta fase é muito dolorida e extremamente importante para a recuperação.

Agenda:

O uso de uma agenda passa a ser **fundamental** nesta fase, e eu acredito que seria indispensável. Todo domingo, o paciente **deve** sentar-se para organizar sua agenda da semana seguinte. Não importa onde o paciente prefira fazer a agenda, o importante é ter esse hábito.

Todo e qualquer evento, refeições, exercícios, leitura, televisão, trabalho, reuniões, encontros e até mesmo o horário de ócio devem ser **registrados**.

planejamento diario.

6:00	ACORDAR	
7:00	MEDITACAO	
8:00	YOGA E BANHO	
9:00	CAFE DA MANHA	
10:00	ACADEMIA	
11:00	HORA VAGA	
12:00	ALMOCO	
13:00	DESCANSO	
14:00		
15:00		
16:00	TRABALHO	
17:00		
18:00		
19:00	JANTAR	
20:00	TELEVISAO/FONE	
21:00		
22:00	DORMIR	
23:00		

PRIORIDADES

- 1 acordar e dormir nos horarios designados
- 2 trabalhar no projeto tal
- 3 meditacao

LEMBRETE



nao faltar academia

AGRADECIMENTO DO DIA

mais um dia sem drogas

GARRAFAS DE AGUA



PARA AMANHA

ir aos grupos de apoio

Acordei - qual o horário? O adicto precisa se acostumar a acordar por volta das 6 da manhã e dormir por volta das 10 da noite. Quanto mais disciplinada a pessoa for em relação a isso, mais chances de recuperação ela tem.

Qual é o horário em que tomará o café da manhã? Precisa estar na agenda. Incluo aqui a prática de meditação e yoga.

"Ah, mas eu não consigo meditar ou fazer yoga." Aprenda!

Existem inúmeros aplicativos que podem auxiliar o paciente. O objetivo aqui é manter a tranquilidade do momento em que acordou até o fim do dia, e a meditação é uma ótima ferramenta.

O yoga também entra aqui e, igualmente, tem uma função linfática e relaxadora, pois alonga o corpo e estimula a liberação de endorfina, o que é bem diferente de dopamina.

Novamente, estes hábitos são saudáveis e têm milhões de benefícios. O importante é não deixar nenhuma situação com altas doses de dopamina atingir o paciente neste período matinal, mantendo, assim, seu estado basal baixo.

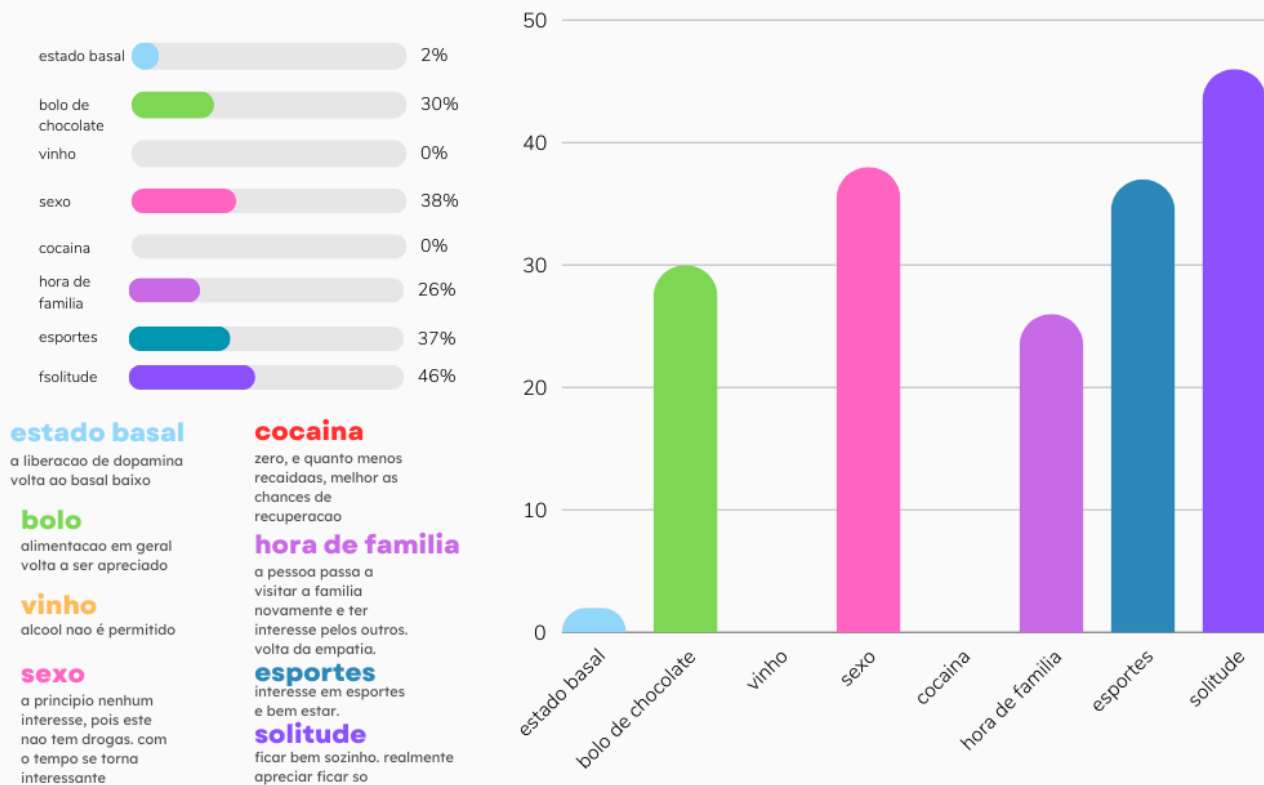
Abaixo, eu coloquei uma tabela dopaminérgica do paciente em recuperação e abstinência.

Repare que as liberações de dopamina são bem menores, pois o paciente não está mais na fase de "dopamine junkie".

As doses de dopamina são muito bem organizadas com a agenda diária.

O paciente volta a ter empatia e, com isso, o interesse pelas pessoas, especialmente familiares e amigos íntimos.

TABELA DOPAMINERGICA EM ABSTINENCIA



E por aí vai... adicionar o horário do almoço, lanche, jantar, TV e o horário de dormir. Cada dia tem a sua particularidade, lembrando que situações que envolvem liberação de dopamina devem ser evitadas ao máximo ou balanceadas durante a semana. O objetivo aqui é transformar a próxima semana em algo dolorosamente previsível, eliminando assim as situações surpresa e diminuindo ao máximo a agitação do dia a dia, pois tudo, absolutamente tudo, já está pré-determinado.

Obs.: as situações surpresa podem ser sentimentos específicos que surgem repentinamente devido à falta de programação, alta exposição inesperada ao álcool, situações estressantes, uso abusivo e compulsivo de doces, compras em excesso, possíveis encontros com pessoas com as quais o paciente não possa se encontrar, situações de ócio inesperadas e não agendadas, filmes e séries com cenas fortes envolvendo a droga de escolha ou qualquer outra droga ou álcool, etc.

O uso dessa agenda funcionará durante muito tempo, às vezes anos. Com o tempo, tudo isso fica tão automático que o paciente nem percebe que está fazendo esse trabalho todo.

Terceira fase:

"Entendi o que fazer para gerenciar minha compulsão, agora está na hora de entender o que desencadeia a compulsão desenfreada."

A terceira fase envolve algum tipo de tratamento psicológico ou grupos de apoio, juntamente com novas ferramentas de prevenção de recaídas, aumentando assim o entendimento sobre os mecanismos que, ao serem acionados, levam à compulsão.

A compulsão, como já vimos, é algo genético e imutável. Sendo assim, o adicto será sempre compulsivo, mas a partir de agora ele terá mais entendimento sobre sua doença e sobre maneiras de gerenciar essas compulsões para que não desencadeiem uma recaída.

Funciona como se o paciente descobrisse que tem diabetes. Ele entendeu que precisará se organizar para sempre medir a insulina no sangue, aplicar os remédios recomendados e melhorar sua dieta da melhor forma possível.

A "recaída", aqui, seria o caso desse paciente com diabetes deixar de usar o remédio, deixar de medir a insulina no sangue ou até mesmo descontrolar sua dieta e abusar de alimentos ricos em açúcares e carboidratos.

A doença da compulsão funciona exatamente como a do diabetes: o paciente precisará, para sempre, prestar atenção em seus sentimentos, monitorar suas reações às casualidades da vida, provavelmente tomar remédios que o ajudem a controlar a ansiedade ou a depressão, e jamais abusar de interações que gerem exposição a qualquer coisa ou ideia que possa levar à compulsão. Quando o paciente começa a se desleixar com essas pequenas regras, ele provavelmente irá recair.

Tudo começa com a falta de monitoramento das emoções, o que pode gerar nervosismo, agressividade, irritabilidade, tristeza infundada ou qualquer sentimento intenso, até mesmo se apaixonar rapidamente e de forma avassaladora.

A partir daí, ele já acha que não precisa mais tomar os remédios e começa a fazer o desmame devagar, pois acredita estar curado.

Neste mesmo período, ele começa a se expor, cada vez mais, a ambientes, lugares ou situações de luz vermelha, ou com alta ativação de dopamina, possivelmente relacionadas à sua compulsão original, às vezes desencadeando uma nova compulsão, geralmente comportamental (sexo, jogos, compras, comida, amorosa...), ou até mesmo diretamente relacionada à compulsão original, voltando assim a usar o álcool ou a maconha, a princípio, e depois migrando para as drogas mais pesadas ou comportamentos mais destrutivos.

Ploft! Recaiu...

Esta fase pode durar o tempo que o paciente achar necessário.

O importante aqui é descobrir quais situações colocariam este paciente em grave risco de recaída.

A constância no tratamento com um psicólogo, ou em grupos de apoio como o AA, é de extrema importância.

O paciente poderá ver um psicólogo uma vez por semana, no mínimo, e, preferencialmente, frequentar algum grupo de apoio diariamente.

Hoje em dia, existem diversos tipos de grupos de apoio. O AA e o NA são muito conhecidos e geralmente permitem visitas online. Os grupos de apoio pagos em clínicas de reabilitação, ou o hospital-dia, permitem maior privacidade e inclusão em um grupo seleto de integrantes, além de um atendimento mais personalizado. Existem também grupos de apoio em igrejas ou instituições religiosas de bairro que ajudam de forma constante.

O importante é ser resiliente!

Não falte aos grupos, mesmo quando não quiser ir, vá!

Faça disso uma prioridade durante algum tempo, muitas vezes anos. Com o tempo, o paciente passa a desenvolver apego ao grupo e finalmente conseguirá tirar proveitos que vão muito além do gerenciamento da adicção.

Cada paciente tem seu "calcanhar de Aquiles", ou seja, uma situação ou sentimento que, quando ocorre, torna-se muito difícil escapar de uma recaída. Para entender melhor esse mecanismo, é importante compreender bem o que leva o paciente a usar drogas. Por isso, seria muito benéfico ter acompanhamento psicológico, mas, caso isso não seja possível, recomendo

que o paciente faça um plano de abstinência, que pode ser escrito à mão ou no celular mesmo, explicando:

1. **O motivo pelo qual o paciente quer parar de usar drogas** — aqui inclui tanto as drogas lícitas quanto as comportamentais.
2. **Por quanto tempo o paciente quer parar de usar drogas?**
3. **Quais as drogas que o paciente decidiu parar de usar?**
4. **Qual o plano de ataque?** Como o paciente irá parar de usar drogas? Aqui, deve-se incluir um plano muito detalhado com as ações a serem tomadas.
5. **Quais as situações ou sentimentos de absoluto perigo para esse paciente?** Pode ser uma pessoa que, caso o paciente encontre, pode disparar uma sequência de ações que levarão à recaída. Pode ser a sensação de ócio ou compulsão pelo trabalho. Pode ser a possibilidade de estar sozinho em uma outra cidade ou em um hotel sozinho. Pode ser um encontro amoroso com uma nova pessoa. Pode ser situações relacionadas ao sexo. Pode ser várias delas em conjunto. Aqui, é importante ser muito honesto e escrever exatamente o que o paciente teme, para assim conseguir identificar com precisão as situações a serem evitadas.
6. **Por último, o paciente deve escolher uma pessoa próxima a ele/ela e mostrar o plano de abstinência.** Precisa ser uma pessoa de confiança e, geralmente, é preferível mostrar o plano a um psicólogo ou aos integrantes de um grupo de apoio. Caso isso não seja possível, o paciente pode escolher uma pessoa — amigo(a), irmão(ã), primo(a) ou alguém em quem se possa confiar segredos. Esta pessoa será o suporte do paciente durante o processo de abstinência e recuperação. Ela precisa ter certeza de que está disposta a se juntar ao tratamento e se transformar em um conselheiro para o paciente. Sempre que o paciente estiver com alguma dificuldade, medo, agitação, euforia ou qualquer sentimento relacionado a uma possível recaída, ele deverá imediatamente ligar para seu "conselheiro" para conversar sobre o assunto. Caso necessário, o "conselheiro" precisará ir ao encontro do paciente para impedir a recaída.

Existem outras técnicas para impedir a recaída quando o paciente sente a iminência dela, como:

Banho gelado funciona bem.

Ligar para alguém para conversar.

Sair da situação em que se encontra, seja ela uma festa ou encontro com amigos.

Comprar algo bem gostoso para comer.

Escrever em algum lugar como está se sentindo.

Entrar em contato com o psicólogo ou integrante do grupo de apoio.

Tomar um remédio para dormir e deitar na cama.

Gritar!

E por aí vai... é necessário entender que está em uma situação de emergência e não se deve ter medo de incomodar as pessoas ou vergonha de pedir ajuda. Com certeza, as pessoas que estão em sua vida nessa etapa do tratamento preferem ser incomodadas do que lidar com uma recaída sua.

Preciso explicar aqui que, muitas vezes, nada disso funciona porque o paciente já pode ter passado pelo ponto sem retorno.

Existe um ponto em que o paciente está tão envolvido com a previsível recaída, que nada do que ele ou outros façam irá tirá-lo do perigo.

Eu chamo isso de "event horizon de um buraco negro".

Você pode até chegar próximo a um buraco negro, mas existe um ponto, ou *event horizon*, do qual não há retorno. Uma vez passado esse ponto, o objeto, ou você, é esticado para dentro do buraco negro por conta da força gravitacional deste, e não existe nada no universo que evite esse acontecimento.

Quando o adicto começa a marinar a ideia de ter um lapso, ele o faz sozinho e em silêncio. A doença vai se mostrando cada vez mais forte e inteligente. O desejo pela sensação que a droga poderá lhe fornecer começa a tomar forma, e o adicto, neste momento, está bem próximo de uma possível recaída.

A partir do momento em que esse paciente começa a planejar seu escape da abstinência, seu destino está traçado. Muito raramente ele consegue sair de um lapso.

O planejamento e a antecipação são muito mais poderosos do que o uso da droga concreta e palpável.

É muito difícil conter esse desejo gigante de planejar o uso.

Manter o paciente sempre engajado nas regras de prevenção à recaída é a melhor forma de impedir que ele chegue a esse ponto complicado.

A exposição contínua ou recorrente a pessoas, lugares e situações relacionadas à sua droga de escolha pode acarretar uma aproximação desse ponto sem retorno.

A exposição à substância em si também pode levar o paciente à boca do buraco negro.

Mentiras constantes ou recorrentes também podem levá-lo a desenvolver um vício por mentir, pois todo adicto é um mestre de mentiras e omissões, criando, assim, uma "vida paralela" que resultará em uma recaída.

É importante entender que essa vigilância deve ser muito forte nos primeiros 6 meses de tratamento. Com o tempo, o paciente passa a ficar muito mais esperto em evitar recaídas, e tudo passa a se tornar mais automático, mas saiba que ele deverá manter atenção pelo resto da vida.

Nesta fase, também é considerável, se possível, abrir para amigos e familiares o que está acontecendo com o paciente.

Aqui, depende de quão confortável o paciente se sente em falar abertamente para todos que tem um problema de adicção e, às vezes, até especificar a substância ou comportamento viciante.

Na minha experiência, isso funcionou muito bem. Eu acabei adicionando uma camada a mais de proteção contra recaídas, pois meus familiares e amigos estavam me apoiando e ajudando no meu plano de abstinência.

Com o tempo, fiquei tão craque em dizer a verdade que, automaticamente, dizia para garçons e bartenders que estava em recuperação e que não bebia álcool.

Foi nesse momento que comecei a achar muito chique não beber! Rs

As pessoas começam a te olhar diferente, com muito zelo e interesse pela sua história. Acho que a honestidade adiciona uma camada a mais na sua personalidade, te distanciando de um ser superficial, a qual já estava acostumado, pois todo adicto é muito superficial.

No fim, acabei ajudando muitos amigos e parentes em suas lutas contra a adicção de diversos tipos.

Também é muito importante nesta etapa que o paciente relate seu histórico de uso, ou da compulsão comportamental, descrevendo detalhadamente:

- Quando teve o primeiro contato com a droga de escolha.
- Como se sentiu nesse primeiro contato.
- Como foi o desenvolvimento e aceleração desse uso ao longo dos anos.
- O paciente aplicou alguma técnica para controlar o uso? Quais técnicas?
- Quais formas ele encontrou para esconder o uso? Foi preciso esconder de alguém?
- Como foi o uso durante os últimos meses? Como o paciente se sentia nesses meses antes de procurar ajuda?
- Como o paciente conseguiu entender que precisava parar de usar? Quem o ajudou nessa decisão? Quais técnicas foram utilizadas para finalizar o uso?
- Finalmente, quais as grandes perdas que ele teve com o uso dessa substância ou comportamento compulsivo?

Sempre que falamos de "grandes perdas", procuro entender qual foi o grande catalisador dessa mudança.

Muitos pacientes precisam passar por "grandes perdas" para decidirem parar de usar drogas ou interromper uma mania compulsiva, como jogos, sexo, compras, etc. Quando o paciente chega ao ponto de perder algo muito estimado, ele começa a enxergar o tratamento de outra forma, vendo-o como a única solução para seus problemas.

O uso compulsivo de uma substância psicoativa não começa como algo ruim; pelo contrário, começa como algo prazeroso, que, na maioria das vezes, parece ser o remédio mais adequado para os problemas que o paciente tem consigo mesmo. Geralmente, esses problemas estão relacionados ao sentimento de dor, seja ela psíquica ou física. A substância psicoativa, então, surge como uma forma de aliviar essa dor e mudar a química do cérebro, de modo que a nova pessoa, sob a influência da substância, se sinta diferente ou livre da dor existencial.

Com o tempo e o abuso contínuo dessas drogas, o paciente começa a perceber que a quantidade de substância deve ser sempre ajustada, pois a dose inicial já não surte o efeito que surtia no começo do uso. O tempo passa, e as quantidades aumentam, até que o uso da droga passa a ser necessário para funções naturais do corpo humano, como acordar, dormir melhor, trabalhar, conversar, fazer sexo, abrir ou inibir o apetite, entre outras. Nesse ponto, o paciente já entrou na última fase do uso, que resultará nas maiores perdas, sejam elas românticas, sociais, familiares, profissionais, financeiras, etc.

O paciente, nesse estágio, ou busca tratamento ou se enterra nas drogas, frequentemente acabando em lugares como a crackolândia. Por sorte, temos os familiares para nos resgatar. Na minha concepção, somente os familiares conseguem resgatar o paciente desse estado gravíssimo. Amigos e colegas geralmente abandonam o paciente assim que o uso se torna tão abusivo que começa a prejudicar a todos ou causa vergonha.

Quarta fase:

"Perseverança tornar-se-á característica mais importante, treine-a, pois como qualquer outra característica, esta também pode ser construída."

O paciente encontra-se agora há alguns meses sem o uso da substância ou da mania compulsiva. Infelizmente, esta é a fase em que mais acontecem recaídas e desistências do tratamento. Existem dados que indicam que apenas 10% dos pacientes em recuperação conseguem realmente finalizar o uso de drogas por completo. Eu prefiro não olhar para esses dados e seguir em frente, sem a necessidade de me comparar com outros pacientes em recuperação.

Agora, é imperativo o cuidado com as rotinas estabelecidas durante os últimos meses. Elas são recomendadas até mais ou menos um ano de tratamento. Se o paciente perceber que está se descuidando neste aspecto, deve procurar ajuda com seu conselheiro ou psicólogo (ou até nos grupos) e se esforçar para colocar sua rotina em dia.

Na quarta fase, a agenda do paciente deve estar automatizada; ele já não frequenta mais qualquer evento dopaminérgico e entende perfeitamente a regra dos sinais vermelho, amarelo e verde. Mesmo assim, a possibilidade de recaídas é grande, pois o paciente se sente excessivamente confiante. Muitas vezes, ele se sente "curado", mas lembrando que esta doença não tem "cura". As recaídas acontecem repentinamente, aparentemente, mas não é bem assim. Elas começam muito tempo antes do ato de usar a droga.

As recaídas ou lapsos vão sendo construídas ao longo de semanas. O paciente, geralmente, nem percebe que uma recaída está se aproximando, a não ser que esteja bem atento ou participando de algum grupo terapêutico, como o AA ou NA. Isso porque os outros integrantes do grupo começam a notar e apontar falhas e descuidos ao longo do tempo, alertando-o de uma recaída iminente.

Motivos para o início das recaídas:

- Confiança exagerada no aprendizado do tratamento, ou seja, falta de humildade.
- Ideia de ter se curado.
- Abuso de exposição a lugares, pessoas e situações relacionadas com o uso.
- Relaxamento na frequência de grupos terapêuticos ou consultas com psicólogo.
- Saudade da experiência que a droga proporcionava no começo do uso.
- Falta de um propósito de vida.
- Os hábitos do paciente continuam os mesmos, exceto pelo uso de drogas ou álcool.
- Mentiras constantes.
- Relacionar-se com outros dependentes químicos.
- Vontade de arrumar alguma confusão. O paciente se sente ocioso ou com uma vida muito pacata e busca ações dopaminérgicas. Na maioria das vezes, essas ações não estão diretamente relacionadas à droga de escolha a princípio, mas, com o tempo, inevitavelmente, vão se transformar no desejo pela substância escolhida.
- Não conseguiu criar novos hábitos saudáveis.
- Não conseguiu entender o que o levou às drogas ou ao comportamento compulsivo e, por isso, não conseguiu cuidar de sua dor.
- Não conseguiu construir uma persona em recuperação, aquela que larga tudo e foca exclusivamente no tratamento da dependência. Não entendeu ainda que, se não se tratar, nada irá para frente.

Poderia citar mais situações, mas acredito que dá para entender o que quero dizer: **não vacile nem por um minuto**, pois a dependência encontra caminhos sinuosos e, aparentemente, dóceis e seguros para conquistar o paciente novamente.

A dependência também pode se manifestar de outras maneiras, como, por exemplo, no abuso de doces ou alimentos em geral, em compras excessivas, no uso exagerado de aplicativos de mídia social, no exagero no consumo de cigarros, no excesso de tempo em frente à televisão, e etc.

É importante salientar que qualquer excesso, até mesmo nos treinos em academia, pode elevar a probabilidade de uma recaída. Controlar esses excessos será a história de vida do paciente. O motivo disso acontecer é que o cérebro começará a procurar prazer ou a elevação da liberação de dopamina no corpo. O cérebro, neste momento, está em um estado basal e muito tranquilo, após tanto tempo sem o uso de drogas ou situações dopaminérgicas. Se o paciente falhar em incluir novas ações em sua rotina que gerem uma sensação de satisfação, ele corre o risco de o cérebro voltar a procurar ações dopaminérgicas.

Aqui, falo pela primeira vez em **satisfação**. O que é isso?

Sentir-se satisfeito com a vida nada mais é do que realizar ações que proporcionarão deleite a longo prazo, diminuindo ao máximo as ações que geram prazer instantâneo. Quando o paciente tiver esse basal dopaminérgico sob controle, ele então pode começar a pensar no futuro:

- O que eu devo fazer hoje para que, daqui a 1 ano, eu receba um prêmio?
- O que eu posso fazer hoje para que, daqui a 5 anos, eu receba um prêmio?

Obs: O prêmio pode ser um novo emprego, conquistar um amor, mudança de carreira, investimento financeiro, melhora familiar, etc.

Pensando assim, o paciente começa a realizar atividades que promovem o prelúdio de um propósito de vida. Ao ver esse propósito de vida se formando diante de si, ele começa a sentir-se bem e satisfeito.

Essa etapa pode levar meses, ou até mesmo anos, para se estabelecer concretamente, mas, ao seguir esse pensamento de incluir mais atividades que levarão mais tempo para gerar recompensas, o paciente começará a sentir-se cada vez melhor com sua recuperação.

Sem falar que ele começa a treinar sua capacidade de ser paciente e de resistir firmemente aos impulsos e desejos que surgem em sua mente, fazendo dessa habilidade uma ferramenta poderosa para o futuro.

Eu chamo essa sensação de satisfação de **"presentes da vida"**.

Esses presentes começam a aparecer com muita frequência: uma promoção no trabalho, uma viagem inesperada com a família, agora possível; acúmulo de dinheiro; rendimento nos treinos de academia, resultando em um corpo mais bonito; a sensação de um corpo saudável; melhora na alimentação; sono mais tranquilo e ininterrupto; a compra de uma nova casa; sensação de paz; animais de estimação (aliás, aconselho fielmente a adoção de animais de estimação que serão responsabilidade do adicto; não consigo expressar o quanto essa simples adoção mudou meus parâmetros de responsabilidade e rotina na minha vida de adicto em recuperação); e muita sorte. Aparentemente, o universo conspira a seu favor quando você está tendo sucesso em seu tratamento.

Mas existem recaídas, e aqui começarei a falar delas.

Recaída ou lapso?

Recaídas são denominadas quando o paciente, em recuperação, volta a usar sua droga de escolha ou sua compulsão comportamental por um período de tempo que ultrapassa um dia ou continua no uso até que seja forçado por alguém, ou por alguma circunstância, a parar.

Lapsos ocorrem quando o paciente em recuperação usa a droga de escolha por um período de até um dia. Ele pode até ter planejado o uso por alguns dias, mas, ao usá-la, não ultrapassou o limite de um dia. Ou seja, logo que percebe o que havia feito, ele para de usar as drogas ou interrompe o comportamento destrutivo.

Essas nomenclaturas são importantes, pois alteram o impacto que o ato tem no tratamento do paciente. **As recaídas**, por serem mais duradouras, têm um grande impacto no tratamento, muitas vezes levando o paciente a desistir completamente.

Contudo, **as recaídas** muitas vezes podem ajudar o paciente a perceber que não existe uma vida interessante ou duradoura durante o uso. Muitas recaídas acabam sendo catalisadoras de uma recuperação séria.

Então, se houver uma recaída, levante-se e continue o tratamento. Não deixe que essa derrota cause danos profundos, pois elas fazem parte do processo de recuperação.

Nos **lapsos**, o paciente já percebe automaticamente que estava fazendo algo errado e não prolongou o uso, o que mostra que ele está em contato direto com seu tratamento. Este paciente consegue parar de usar e retornar ao tratamento com mais facilidade, pois o peso dessa nomenclatura, "lapso", não o sobrecarrega, deixando um sentimento de falha, mas não de decepção profunda, como geralmente ocorre com as recaídas.

Nos dois casos, existem regras a serem seguidas para que o lapso ou a recaída não se transformem em um retorno completo ao mundo das drogas ou ao comportamento compulsivo destrutivo:

1. **Assim que perceber a falha no tratamento**, procure imediatamente seu psiquiatra ou psicólogo. Caso não tenha essas ferramentas, procure o responsável por você ou a pessoa que decidiu embarcar nesse tratamento para ajudá-lo a sair das drogas.
2. **Abra o jogo**: conte tudo o que aconteceu, como aconteceu e há quanto tempo vinha planejando essa recaída ou lapso.
3. **Isolamento temporário**: se tranque em algum lugar. Seja em sua casa ou em um lugar seguro, como uma casa de repouso ou internação por livre arbítrio.
4. **Nos próximos 3 dias**: é extremamente importante que o paciente não tenha nenhum contato com o mundo externo, nem mesmo por telefone (que, aliás, deverá ficar guardado em algum lugar seguro e longe do paciente). Se o paciente precisar sair de casa, ele deve fazer isso acompanhado pelo responsável ou por acompanhantes do paciente.
5. **Limite a exposição a estímulos**: evite filmes ou seriados com grande descarga de adrenalina. Limite também alimentos estimulantes, como café e energéticos.
6. **Fale sobre o ocorrido**: tenha alguém com quem conversar sobre o que aconteceu. O importante aqui é tentar entender o que o levou a recair. Quando o paciente começou a pensar em drogas? Quando as mentiras começaram a surgir? (Tenho absoluta certeza de que elas começaram a ocorrer com frequência algumas semanas antes). Como conseguiu obter as drogas? Quem foi o facilitador? Com essas respostas, o paciente conseguirá se prevenir melhor no futuro.
7. **Volte à agenda diária**: planeje a próxima semana de forma minuciosa, como fazia no início do tratamento.
8. **Retorne à rotina após o isolamento**: depois de 3 dias de isolamento, retorne à rotina, mas mantendo as situações dopaminérgicas fora dela. O objetivo é restaurar seu estado de agitação para um estado basal, neutro, mais tranquilo e sereno.

Vou salientar aqui a importância de o paciente entender que, **não importa a substância de escolha**, o álcool **nunca será** permitido durante o processo de recuperação. **Afirmo com convicção que**, para que este processo tenha sucesso, o paciente deve estar pronto para dizer adeus ao álcool também. **Destaco isso em negrito, pois vivenciei isso pessoalmente**. Quanto mais cedo o paciente entender esse ponto, mais rápida e menos dolorosa será sua recuperação.

Bom, seguindo essas **orientações pós-recaída**, o paciente **vai se acalmar**, voltando seu estado de agitação para um nível basal e conseguindo ter a mente mais clara para retomar o tratamento. A cada recaída ou lapso, aprenderemos um pouco mais sobre nós mesmos e nossas limitações. **Por isso, assumo a responsabilidade pelo erro, mas não se lamente indefinidamente**. Perdoar a si mesmo também faz parte do tratamento.

Quinta fase:

"Deixando o meu EU verdadeiro aparecer"

O paciente, nesta fase, já tem bastante tempo de tratamento, mesmo que seja um tratamento mais informal, e já entende bem sobre recaídas e lapsos. Ele começa a construir sua nova vida e a entender quem ele realmente é em seu âmago, iniciando também o tratamento da dor que o levou ao uso de drogas ou a um comportamento compulsivo. Acredito que é neste momento que novos valores começam a se formar. O paciente passa a se dedicar mais à família e aos amigos próximos, volta a trabalhar, talvez a se relacionar, mas tudo isso sempre com os seguintes cuidados:

Entender que, enquanto paramos de beber ou usar drogas, o mundo continuará bebendo e usando drogas. **Por isso, teremos que ter muito cuidado com nossa exposição.**

Explicando o tempo de exposição:

O tempo de exposição será o período inteligentemente controlado em que o paciente se expõe a lugares, pessoas e ambientes de alta ativação dopaminérgica, ou que estejam relacionados ao uso específico da substância de preferência do paciente. Esse tempo de exposição geralmente inclui qualquer substância ou atividade que o leve a contemplar o uso.

Vou me colocar como exemplo para facilitar o entendimento:

Depois de alguns anos de tratamento e compreendendo bem os mecanismos que me levaram ao uso abusivo de cocaína, consegui entender que, para mim, os ambientes de alta ativação dopaminérgica são um dos meus principais gatilhos.

Eventos com música alta e muita gente, festas pequenas na casa de amigos, bares e clubes formam a superfície dos lugares nos quais preciso -para sempre- ter muito cuidado. Faço isso limitando meu tempo de exposição em cada ambiente em que preciso ir. Se precisar ir a uma festa de aniversário, o foco principal aqui será homenagear o aniversariante e conversar com algumas pessoas durante a festa. Por ser um ambiente onde o álcool é amplamente consumido e as drogas podem ser percebidas nas ações dos participantes, dou-me no máximo duas horas de exposição.

Antes de decidir se vou à festa ou não, faço as seguintes perguntas para mim mesmo:

- Onde será a festa? Já estive neste local antes? Usei drogas ou bebi álcool neste ambiente?
- Quem irá à festa? Existe alguém que use ou tenha usado cocaína, no meu caso?
- Onde geralmente fica o bar? Consigo pedir algo sem álcool nesse bar ou preciso ir a algum lugar específico? Dessa forma, já me posiciono longe do bar com álcool.
- Como posso sair do ambiente sem ser visto depois de duas horas? É importante ter uma rota de fuga, caso a exposição comece a me fazer pensar que “um drink não fará mal”. Se esse pensamento surgir, fuja imediatamente do local.
- Com quem preciso conversar na festa? Quem devo evitar?
- Onde ficam os banheiros? Pois é nos banheiros que o uso da cocaína costuma ocorrer. Se precisar ir ao banheiro, peça a alguém para lhe acompanhar, alguém que saiba sobre o seu problema ou um acompanhante.
- Já aproveitando este momento: não vá sozinho! Leve sempre o seu acompanhante, conselheiro, amigo que saiba sobre o seu problema ou responsável por você.

E, por fim, depois de analisar tudo isso e decidir ir à festa, pergunte-se:

Vale a pena ir a tal festa?

Muitas vezes, após responder a esses questionamentos, acabo decidindo não ir ao evento, pois o considero muito perigoso (sinal vermelho ou amarelo) ou não acredito que a exposição valha a pena. Prefiro, muitas vezes, encontrar o aniversariante depois do evento para almoçar e lhe presentear.

A exposição é cumulativa. Quanto mais você se expõe, mais chances você tem de normatizar ambientes com alto teor dopaminérgico, ou que contenham álcool. Assim, em um belo dia, você pode achar que já pode beber um vinhozinho com amigos, e isso, inevitavelmente, o levará a uma recaída com a sua droga de escolha.

Portanto, é melhor construir uma vida nova sem o álcool. Falo dele em particular porque é através dele que a sua droga de escolha o encontrará. Aceite que, provavelmente, você jamais poderá beber novamente. Isso pode parecer algo enorme e difícil de imaginar, mas, na verdade, é como qualquer vício: depois de algum tempo, o desejo pelo álcool não será tão pronunciado e você desejará outras coisas para sua vida.

O que me leva agora para o tema da transferência de vícios:

Durante a trajetória do tratamento contra o vício, geralmente focamos na interrupção do uso da droga de escolha do paciente, e sempre estendemos esse foco ao álcool, mesmo que este não seja seu vício principal. Quando aprendemos a domar o vício principal e o álcool, nosso "bichinho" da compulsão fica louco procurando outra substância ou comportamento que o leve a algo distantemente parecido com o que vivíamos durante o uso abusivo da substância de escolha.

Esse "bichinho" da compulsão é muito inteligente, pois ele procura substâncias ou comportamentos que, na verdade, não fazem tão mal quanto a droga de escolha. Ele sabe que o paciente está blindado contra pensamentos sobre a droga de escolha, e, nesta fase, o paciente desenvolve uma verdadeira aversão a ela.

No entanto, essa aversão é um sentimento falso. Se o paciente for apresentado à droga de escolha em um ambiente fechado e sem a presença de outras pessoas, ele certamente a usará. Portanto, digo que essa repugnância é falsa, mas funciona para controlar as memórias eufóricas ligadas ao uso da substância.

Com o mecanismo de defesa bem forte contra a droga de escolha e o álcool, o "bichinho" da compulsão começará a procurar novos caminhos para conquistar o paciente novamente. Isso ocorre porque o prazer é algo que o ser humano busca constantemente, e ele é o maior inimigo do paciente em recuperação.

Se o paciente começar a permitir atividades, ações, situações e pessoas que lhe dão muito prazer — principalmente quando esse prazer é imediato — ele estará se aproximando de uma recaída. Ninguém vive sem prazer. O que estou dizendo aqui é para moderar o prazer, tomá-lo em doses pequenas e espaçadas. Acredito que, assim, o paciente terá uma chance de criar novos hábitos relacionados com a satisfação, ou seja, aqueles cujas recompensas virão com o tempo, e salpicar prazeres nesta receita de forma inteligente e racional.

Tenha prazer, mas pense antes e veja se ele está de acordo com o seu plano de recuperação. Se você achar que esse prazer tem algum contato, mesmo que escondido, com o seu prazer destrutivo, evite-o.

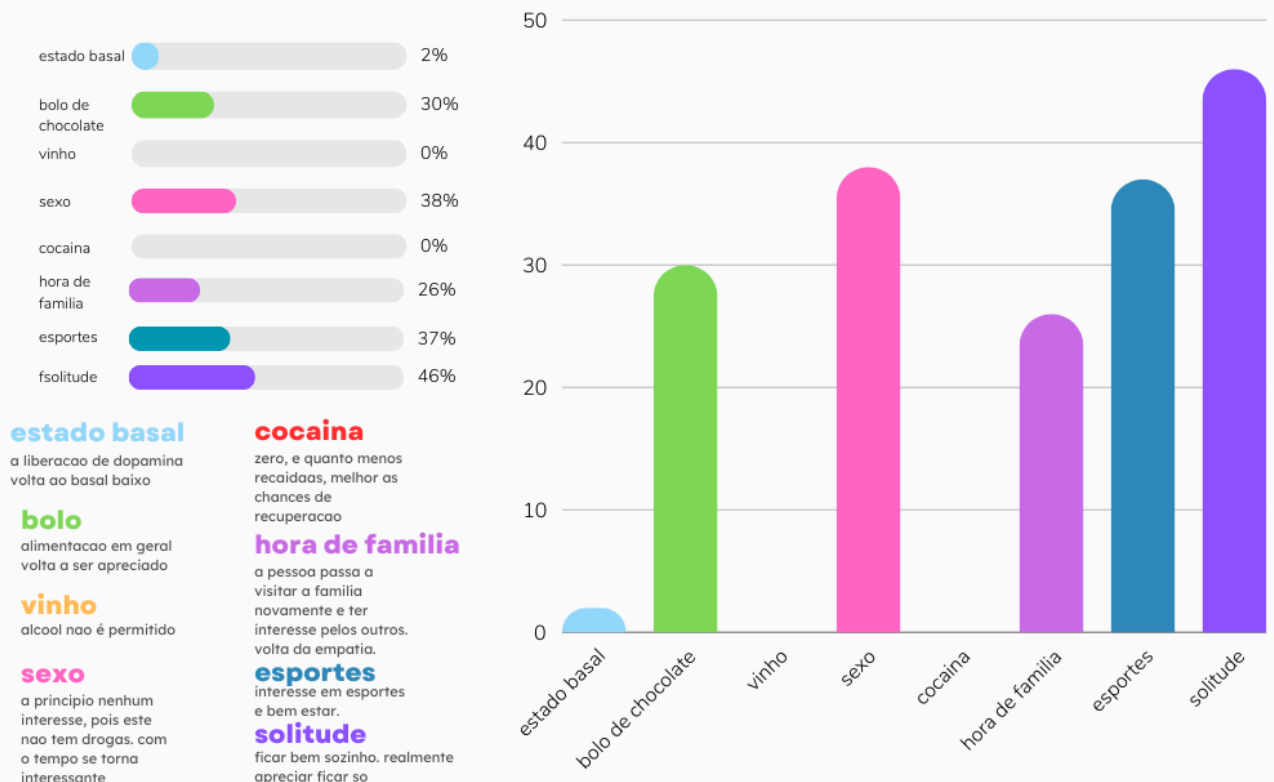
Lembre-se: nem todo prazer é físico ou palpável. Preste atenção também nos prazeres da mente. Isso mesmo, monitore o que você consome mentalmente: redes sociais, livros, filmes, séries, conversas, pensamentos e por aí vai.

O "bichinho" da compulsão aparecerá fantasiado de diversas formas, entre elas:

Doces, alimentação, exercícios físicos, esportes de alta adrenalina, entusiasmo por certos tipos de shows na televisão, compras, infidelidade, novos relacionamentos com pessoas demasiadamente agitadas, sexo, entre outros.

Excessos em geral irão acontecer durante o tratamento. Estes excessos, mesmo que positivos, como no caso dos exercícios físicos, podem gerar altas descargas de adrenalina ou até mesmo dopamina, mantendo o paciente em um estado constante de agitação. O objetivo, durante o período crítico do tratamento, é manter seu estado basal de dopamina ou adrenalina controlado e sempre em nível basal. Assim, o paciente terá a chance de voltar, vagarosamente, a experienciar prazer de forma mais natural e equilibrada.

TABELA DOPAMINERGICA EM ABSTINENCIA



Se o paciente, em vez de se manter tranquilo, começar a frequentar a academia por necessidade de saúde, se empolgar e participar de várias aulas, além de se envolver em atividades ao ar livre relacionadas a exercícios físicos recorrentes e esportes de alta adrenalina, ele estará se colocando em risco também.

Tudo começa com 3 dias de academia, 1 hora por dia. Em algumas semanas, já estou indo 5 dias por semana. Começo a conhecer e me relacionar com o pessoal da academia, que só fala sobre exercícios e esportes radicais, algo que anteriormente não me interessava. Passo a falar sobre esses assuntos com mais frequência.

Aparentemente, estou criando um hábito saudável, e não há nada de errado nisso. Com o tempo, passamos a nos encontrar nos fins de semana para fazer trilhas e praticar esportes radicais. Já estou ficando mais de 2 horas na academia e, agora, todos os meus amigos são do esporte. Mostrando bem aqui que já estou abusando de exercícios físicos e me isolando em um grupo específico de pessoas. Lembra de "8 ou 80"? Eu já não vejo algo moderado nessa relação com o esporte.

Nesse meio tempo, por conta dos exercícios físicos, meu corpo começa a se desenvolver e vejo que estou ficando bem musculoso. Como o pessoal da academia usa esteroides, eu passo a usá-los também e percebo uma construção muscular acelerada em semanas. E tem um efeito ainda melhor: minha libido dispara! (Crescimento muscular rápido, como se fosse um cheat code, e prazer instantâneo.)

Com a libido em alta, começo a me encontrar com pessoas para explorar o sexo, o que muitas vezes gera infidelidade no meu caso, pois sou casado. Esses encontros se tornam cada vez mais frequentes. Enquanto isso, continuo com as amizades que só conversam sobre exercícios e atividades de adrenalina, até que decidimos todos saltar de paraquedas em Boituva. Vamos uma vez, depois outra, depois mais uma...

O sexo está frequente e eu já sinto que pode estar se tornando abusivo, mas minha cabeça diz: "Tá tudo tranquilo, você está vivendo uma vida saudável e está muito bonito! Tem que aproveitar mesmo! Eu nem penso mais em cocaína!". Com o passar do tempo, o uso de anabolizantes vai ficando cada vez mais pesado, assim como a libido.

O que leva a mais sexo e mais pensamentos eufóricos sobre sexo e sobre saltar de paraquedas. Até que, um belo dia, durante um encontro sexual, me sinto tão forte e tão resolvido que acho que já posso tomar vinho com a paquera... O vinho se torna frequente, a vida dopaminérgica continua e, quando menos espero, já estou ligando para o taxista que me vendia cocaína antigamente e pedindo para ele me levar até a esquina da minha casa.

Esse exemplo é importante para deixar bem claro as facetas da doença da compulsão.

Enquanto descrevia esse exemplo, já notei uma liberação dopaminérgica gritante dentro de mim — imagina viver essa historinha na pele. O objetivo do tratamento é levar o paciente a sentir prazer de maneira mais natural e longe dos excessos da compulsão. Então, manter-se sempre tranquilo é uma ótima escolha. Quando sentir que está agitado demais, pare e se recomponha, pois existe algo por trás dessa agitação inesperada. Respire fundo, analise o motivo da agitação, procure um espaço aberto e olhe para as árvores, para o céu, para o seu animal de estimação ou algo assim. A sensação de agitação, ou desejo quase que incontrolável de algo que nem você mesmo sabe o que é, passará.

Leva-se em torno de 6 minutos para que um desejo grande ou uma agitação passe. Relaxa, que vai passar!

Na fase 5, o paciente começa a ter prazer em ficar em casa e vê eventos como algo chato e um pouco inconveniente, pois se sente satisfeito com a própria companhia. A vida social se restringe a familiares e amigos íntimos, escolhidos a dedo.

Aqui também, ele começa a se dedicar a causas que vão além dele, como ajudar alguém que está passando por algo parecido. Os valores vão mudando. O paciente passa a ser mais tolerante, mais amoroso, mais gentil, mais doce, mais esperançoso, mais honesto, mais respeitoso, mais seguro, mais leal, mais criativo... o que levará a uma vida abundante e feliz.

A visão de estar sempre em falta de alguma coisa é trocada pela visão da abundância e da gratidão, gerando sentimentos de satisfação pessoal.

Quando paramos de usar drogas, ou com os comportamentos compulsivos, entramos em uma batalha contra o prazer imediato e excessivo. Quando o tratamento é eficaz, ganhamos sentimento de satisfação. Satisfação geralmente demora para chegar, não é como o prazer que é instantâneo, mas esperar pelas recompensas não é doloroso, visto que a construção de uma vida satisfatória já gera um sentimento de bem-estar, e esse sentimento se perdura para sempre.

Não estou dizendo aqui que uma vida longe de compulsões é perfeita; pelo contrário, ela continua sendo complicada e agora cheia de limites, mas, nesse momento, você tem as habilidades necessárias para construir algo tranquilo, longo e a capacidade de lidar melhor com suas inseguranças e transtornos naturais da vida.

Deixar-se sentir sentimentos negativos também faz parte de uma vida bem vivida. Afinal, sentimentos negativos existem por algum motivo importante, e estes não devem ser ignorados; devem ser sentidos e trabalhados.

Então, sinta os sentimentos negativos e positivos. Esteja sempre conectado com seus sentimentos. Aprenda a nomeá-los.

Confrontando o desconforto inicial:

Ao pararmos de usar drogas, lícitas ou ilícitas, ou comportamentos compulsivos, nos deparamos com os sentimentos que nos levaram ao abuso de substâncias psicoativas inicialmente. Estes sentimentos, agora não mais mascarados pelo efeito das drogas, voltam à tona.

Com o auxílio de grupos de apoio ou terapia individual, podemos trabalhar esses sentimentos de forma adequada, para que eles não tenham o efeito destruidor que tiveram quando começamos a usar drogas.

Quando falo "trabalhar os sentimentos", nada mais é do que falar abertamente sobre eles, diversas vezes se necessário, analisando-os de forma meticulosa para entendermos melhor os mecanismos que nos movem em direção às drogas.

Um exemplo sobre isso segue:

Eu era um adolescente extrovertido, mas, por conta da minha orientação sexual, por ser gay, não conseguia fazer parte de nenhum grupo social, pois escondia esse lado da minha vida a sete chaves. Esse sentimento de inadequação foi crescendo, assim como a vontade de ser amado pelas pessoas. A ponto de gerar muitas frustrações, que culminaram em insegurança extrema, o que me fez retrair e me afastar das pessoas.

Até que comecei a conhecer pessoas que tinham as mesmas inseguranças que eu, mas que usavam álcool e drogas para se sentirem normais e bem-quistas. Assim, comecei a usar álcool e drogas também.

No início, me sentia muito melhor e um super-herói. Com o tempo e o abuso dessas substâncias, o "vício" veio cobrar as taxas referentes à sensação de bem-estar que eu havia sentido no começo do uso.

Essas "taxas" são os efeitos negativos do abuso de substâncias, o aprisionamento do seu "eu" antecessor às drogas e a introdução da sua nova persona, agora completamente diferente daquele jovem inseguro e careta.

Assim como quando ouvimos nos filmes e livros que as pessoas entregam suas almas ao diabo, mais ou menos isso acontece quando o compulsivo é sequestrado pelo vício.

O paciente precisa estar pronto para confrontar esses desconfortos novamente, mas agora tomando decisões mais acertadas.

O tratamento de recuperação e reabilitação, para mim, pareceu ser a recuperação do meu "eu" pré-drogas, sabendo agora que tenho as devidas ferramentas para confrontar minhas inseguranças de maneira inteligente e tomar decisões sensatas e mais acertadas para o momento que vivo hoje.

O tratamento inteiro é uma lição profunda sobre como se amar!

Uma imersão dentro de você mesmo para, finalmente, entender melhor a pessoa mais importante da sua vida.

Então, não ache que o tratamento acaba com a fase 5. Ele, na verdade, começa de verdade a partir da fase 5. E está tudo bem, pois o "você" de agora, munido de todo o conhecimento sobre adicção e de todas as ferramentas de prevenção a recaídas, poderá passar o resto da sua vida se conhecendo melhor, se escutando melhor, se perdendo melhor... Não sei pra vocês, mas pra mim está sendo magnífico, e não estou com pressa alguma para chegar a algum resultado específico.

Cada dia amadureço mais, e levo comigo a sensação de satisfação, de ter o suficiente e de que não preciso de mais, ou de abusos, pra me sentir melhor. Eu sou o suficiente!

A minha trajetória com o tratamento de adicção ainda não acabou. Continuo frequentando grupos, ajudando pessoas e sendo ajudado. Aprendo coisas novas sobre a adicção e sobre mim quase diariamente, e agora, em total abstinência, consigo ter a mente preparada para entender mais sobre o mundo e sobre mim mesmo.

Espero que este manual possa ajudar as pessoas que sofrem dessa doença a gerenciá-la, ou pelo menos sair do estado crítico de consumo compulsivo. Espero que esse manual ajude as pessoas a entenderem que essa sensação de liberdade que, erroneamente, achamos que deriva da possibilidade de fazer tudo o que vem na cabeça, na verdade, é uma ilusão. Somos livres, verdadeiramente, quando temos a capacidade de escolher entre usar drogas ou não. Durante o uso de drogas, ou mania de algum comportamento compulsivo, não temos essa opção de escolher, pois estamos aprisionados pelo vício.

"Escolha ser livre. Vai por mim, rs, é bem melhor!"

A liberdade verdadeira não vem da possibilidade de fazer tudo o que queremos, mas da capacidade de escolher. Quando estamos no controle da nossa vida, no controle das nossas escolhas, é quando realmente experimentamos a verdadeira liberdade. E é essa liberdade que você encontrará ao longo do processo, passo a passo. Não se apresse, aproveite cada momento dessa jornada de autodescoberta e crescimento. Acredite, é bem melhor."

Leonardo Oliva
Adicto em reabilitação